

TEMA 1.17 • PEDIATRÍA

Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) en Pediatría

PERFIL EUNACOM 2.01.1.021

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) en Pediatría

1. SBO Agudo (Bronquitis Obstructiva / Bronquiolitis)

- **Causa: VRS (Virus Respiratorio Sincicial)** → 80% de los casos (invierno, campaña hospitalaria).
- También: metapneumovirus, adenovirus, parainfluenza.

Bronquiolitis = primer episodio de SBO en un lactante (por VRS habitualmente).

• **Clínica y signos de severidad:**

- Taquipnea
- **Sibilancias**
- Uso de musculatura accesoria
- Cianosis

Diagnóstico: Clínico (examen pulmonar obstructivo + dificultad respiratoria).

Score de Tal (Severidad del SBO)

TABLA 1.17.1: VARIABLE VS 0 PTS

VARIABLE	0 PTS	1 PT	2 PTS	3 PTS
FR (> 6 meses)	≤ 30/min	> 30	> 45	> 60
FR (< 6 meses)	≤ 40/min	> 40	> 55	> 70
Musculatura accesoria	Sin uso	Subcostal	Intercostal	Cervical (tiraje)
Cianosis	Ninguna	Perioral con llanto	Perioral siempre	Generalizada
Sibilancias	Sin sibilancias	Espiratorias (fonendo)	Espirat. + Inspir.	Audibles sin fonendo / Silencio

TABLA 1.17.2: PUNTAJE VS SEVERIDAD

PUNTAJE	SEVERIDAD
0-5	Leve
6-8	Moderado
9-12	Severo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Silencio pulmonar en un niño grave = 3 puntos en sibilancias (igual que sibilancias audibles sin fonendo). Diferenciarlo por el contexto clínico.

Manejo según Severidad

TABLA 1.17.3: SEVERIDAD VS SCORE

SEVERIDAD	SCORE	TRATAMIENTO	DECISIÓN
Leve	0-5	Salbutamol 2 puff (aerocámara)	Alta a domicilio
Moderado	6-8	Salbutamol 2 puff cada 10 min x 1 hora (5 veces)	Reevaluar en 1 hora; si no responde en 2 horas → hospitalizar
Severo	9-10	Salbutamol + Oxígeno	Si no responde en 1 hora → hospitalizar
Severo extremo	11-12	Oxígeno + soporte	Hospitalización inmediata

Indicaciones de oxígeno: - Score de Tal ≥ 9 (severo) - Saturación < 93%

- **Corticoides sistémicos** (dexametasona VO/IM o prednisona oral): agregar cuando:
- No responde después de 1 hora (moderado o severo)
- Contexto de SBO recurrente (= asma → siempre corticoides en crisis)
- Al hospitalizar

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Puff vs. nebulización: Los puff con aerocámara son **más eficaces** que las nebulizaciones. Las nebulizaciones solo se usan en SBO severo que requiere oxígeno de alto flujo.

NOTA CLÍNICA

El **ipratropio** es alternativa al salbutamol (o complemento) cuando hay efectos adversos al salbutamol (temblor excesivo) o contraindicación (taquicardia, cardiopatía).

2. SBO Recurrente (SBOR = Equivalente al Asma)

Definición: ≥ 3 episodios de SBO en el tiempo.

Causa: Hiperreactividad bronquial post-infección por VRS → exacerbada por nuevos virus.

Diagnóstico: Clínico (3 o más crisis obstructivas).

- **Manejo:**
- Crisis 1 y 2: tratar agudamente, sin tratamiento de mantención
- **Desde la 3ª crisis:** Iniciar tratamiento igual que **asma**:
- - Salbutamol 2 puff SOS (rescate)
- - **Corticoide inhalado** (mantención)
- Solicitar **Rx tórax** para descartar causa secundaria

3. SBO Secundario (Causas Específicas)

TABLA 1.17.4: CAUSA VS CLAVE CLÍNICA

CAUSA	CLAVE CLÍNICA
Cardiopatía congénita	Soplo cardíaco + cardiomegalia → ecocardiograma + cirugía
Fibrosis quística	Diarrea + malabsorción + bronquiectasias + infecciones por <i>Pseudomonas</i> / <i>S. aureus</i>
Discinesia ciliar primaria	Bronquiectasias + situs inversus (dextrocardia) = Síndrome de Kartagener
Displasia broncopulmonar	Secuela de EMH en ex-prematuro → SBO grave en lactante

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Situs inversus + SBO recurrente = Síndrome de Kartagener (discinesia ciliar primaria). Si hay dextrocardia en la Rx, piénsalo.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 3 años llega a urgencias con dificultad respiratoria. Al examen: FR 42/min, uso de musculatura accesoria (intercostal y subcostal), sin cianosis, sibilancias bilaterales. Score Tal: 7. ¿Cuál es el tratamiento inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO) en Pediatría. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Score Tal: evalúa FR + musculatura accesoria + cianosis + sibilancias; leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12
- SBO leve (0-5): 2 puff salbutamol (con aerocámara) → evaluación y alta si SpO₂ >95%
- SBO moderado (6-8): salbutamol 2 puff c/10min x3 en 1h + corticoide sistémico oral o IM
- SBO severo (9-12): O₂ + salbutamol nebulizado continuo + corticoide EV + hospitalizar urgente
- SBO recurrente: ≥3 crisis al año = diagnóstico de asma → iniciar corticoide inhalado preventivo
- Causas secundarias de SBO: fibrosis quística, cardiopatía congénita, displasia broncopulmonar, sínd. de Kartagener

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO) EN PEDIATRÍA)**PREGUNTA 1**

Niño de 3 años llega a urgencias con dificultad respiratoria. Al examen: FR 42/min, uso de musculatura accesoria (intercostal y subcostal), sin cianosis, sibilancias bilaterales. Score Tal: 7. ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A)** Alta con 2 puff de salbutamol y control en 24 horas
- B)** Salbutamol 2 puff c/10min por 3 dosis (1 hora) + corticoide sistémico
- C)** Salbutamol nebulizado continuo + O₂ + corticoide EV + hospitalización
- D)** Adrenalina nebulizada como primera línea
- E)** Antibióticos por sospecha de sobreinfección

PREGUNTA 2

Niño de 5 años con cuarta crisis de SBO en el año. Entre las crisis está asintomático, sin tos nocturna. ¿Cuál es el paso diagnóstico y terapéutico siguiente?

- A)** Test del sudor para descartar fibrosis quística
- B)** Diagnóstico de asma + iniciar corticoide inhalado preventivo
- C)** Espirometría basal y solo si altamente alterada iniciar tratamiento
- D)** Salbutamol de rescate a demanda y seguimiento cada 6 meses
- E)** Ecocardiograma para descartar cardiopatía como causa

PREGUNTA 3

Adolescente de 14 años con sibilancias recurrentes desde la infancia, bronquiectasias en TC de tórax, situs inversus (órganos en espejo) y espermiograma con motilidad espermática alterada. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Fibrosis quística
- B)** Inmunodeficiencia combinada severa (SCID)
- C)** Síndrome de Kartagener (discinesia ciliar primaria)
- D)** Asma no controlada con bronquiectasias por remodelado
- E)** Displasia broncopulmonar

RESUMEN: SÍNDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO (SBO) EN PEDIATRÍA

⚠ Silencio pulmonar en un niño grave = 3 puntos en sibilancias (igual que sibilancias audibles sin fonendo). Diferenciarlo por el contexto clínico. ⚠ Corticoides sistémicos (dexametasona VO/IM o prednisona oral): agregar cuando: 1. No responde después de 1 hora (moderado o severo) 2. Contexto de SBO recurrente (= asma → siempre corticoides en crisis) 3. Al hospitalizar ⚠ tip Puff vs. nebulización: Los puff con aerocámara son más eficaces que las nebulizaciones. Las nebulizaciones solo se usan en SBO severo que requiere oxígeno de alto flujo. ⚠